Établissement

Médecin responsable

PROTOCOLE DE SOINS INFIRMIERS SUR PRESCRIPTION ANTICIPÉE — ARTICLE R.4311-6 (2°) CSP

Hydratation sous-cutanée

Adulte, surtout personne âgée · hypodermoclyse sans signe de gravité

URGENCE VITALE → 15 IMMÉDIAT · ne répond pas, marbrures, PAS < 100 mmHg, pouls > 120/min, trouble de conscience brutal (voie IV, pas SC) ; dyspnée, crépitants, SpO2 < 90 % sous perfusion : **l'arrêter**.

J'applique si

- Boissons **insuffisantes** (refus, déglutition, vomissements, confusion), surtout si fièvre, diarrhée, canicule.
- Déshydratation **légère à modérée** : bouche sèche, urines rares, perte de poids, hypotension orthostatique.

Je n'applique pas → avis médical

- **Déshydratation sévère, choc**, trouble hydro-électrolytique sévère : 15, voie IV.
- **Insuffisance cardiaque décompensée**, œdèmes généralisés, hypernatrémie, anurie.
- Troubles majeurs de l'hémostase ; dermatose ou infection cutanée étendue.
- Enfant : hors protocole.

J'agis

RÔLE PROPRE

1. Constantes, **poids**, diurèse, boissons des 24 h ; cause ; IC, IR, restriction hydrique ? Palliatif : souhait, LAT.

SUR CE PROTOCOLE

2. **NaCl 0,9 %** SC (carte ci-contre) ; cathéter souple **22–24 G**, pansement transparent daté.
3. Sites : flancs, cuisses, sous-claviculaire ; **interscapulaire** si risque d'arrachage.
4. Gonflement : ralentir ; douleur, rougeur, induration, sang : **changer de site**.
5. **Ionogramme, créatinine** dans les 24 h, sans retarder la perfusion ; continuer à faire boire.

SUR AVIS MÉDICAL

6. > 1 L/24 h (max 1,5 L/site, 3 L sur 2 sites), G5 % + NaCl, KCl (≤ 2 g/j).

Consigne orale du 15 ou du médecin → télé-prescription écrite, annexée au dossier.

Perfusion SC

NaCl 0,9 % seul

- pas de G5 % seul, aucun ajout

500 mL en 6 à 8 h

- ≈ 1 mL/min, jamais > 3 mL/min

2 × 500 mL / 24 h max

Même site **6 j** max · durée **48 h**

J'appelle le médecin

- Le jour même : mise en route, résultats ; pas de mieux à 48 h.
- Sans délai : œdèmes, prise de poids rapide, plus d'urines (perfusion arrêtée).

Je surveille et je trace

- Site, débit, fuite **après la pose puis chaque jour** ; boissons, diurèse, poids, **surcharge** ; soluté, date de pose.
- AS/AES : signalent douleur, gonflement, arrachage ; ne touchent pas au débit.

À retenir : L'hypodermoclyse complète la boisson, elle ne la remplace pas. Jamais en cas de choc.

Fait à : .....

Le : ..... / ..... / .....

Signature et cachet du médecin :

Vision Moderne de la Santé

Docs On The Road — Construisons ensemble une santé qui vient à vous.

Références : OMéDIT Centre-Val de Loire, fiche BP&BU Perfusion sous-cutanée (MAJ 10/2017) et Urgences en EHPAD : dotations (02/2025) ; CPias Bretagne, Cathéter sous-cutané (2023) ; ERVMA, La déshydratation en EHPAD (02/2023) ; RCP Chlorure de sodium 0,9 % B. Braun (ANSM, MAJ 20/10/2025) ; arrêté du 26/06/2026 (art. 4 II).

Réf. DOTR-IDE-HSC | Version 3.0 – 11/2026 | Applicable après signature médicale | Révision au plus tard 12 mois après signature